Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde

PONTOS IMPORTANTES

- PONTOS IMPORTANTES
- Definição e Propósito: O Apoio Matricial integra equipes de Saúde da Família (eSF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) para promover a integralidade do cuidado e fortalecer a capacidade resolutiva da Atenção Primária à Saúde (APS).
- Dimensões de Atuação: Opera nas dimensões técnico-pedagógica (educação permanente, discussão de casos, Projetos Terapêuticos Singulares - PTS) e assistencial (consultas conjuntas, visitas domiciliares), visando aprimorar as competências clínicas e a colaboração.
- Desafios na Implementação: Enfrenta barreiras como a carência de conhecimento sobre o modelo, dificuldades relacionais e organizacionais, formação acadêmica inadequada e o estigma associado a certas condições de saúde.
- Práticas e Potencialidades: Materializa-se em práticas colaborativas e possui potencial para expansão por meio da integração intersetorial, uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e incorporação de uma perspectiva culturalmente sensível.

Educação Permanente e PTS

A dimensão técnico-pedagógica do Apoio Matricial é fundamental para o aprimoramento contínuo das equipes de eSF. Recomenda-se a implementação regular de sessões de educação permanente, discussões de casos clínicos complexos e o desenvolvimento conjunto de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) para garantir a atualização do conhecimento e a integração das práticas.

Por meio do matriciamento, as equipes de eSF, que atuam na linha de frente da APS, são apoiadas por profissionais especializados do NASF, constituindo uma rede de cuidado mais robusta e cooperativa. Isso implica que as equipes de referência podem contar com suporte técnico especializado para enfrentar desafios clínicos mais complexos, sem a necessidade imediata de encaminhamentos externos. Em vez de simplesmente referir casos para especialistas, as equipes de matriciamento atuam em conjunto para desenvolver estratégias de intervenção que sejam mais adequadas às necessidades locais e às condições de saúde da população assistida.

Adicionalmente, o matriciamento não se restringe apenas ao aspecto técnico-clínico. Ele promove uma cultura de colaboração e aprendizado contínuo entre os diversos profissionais de saúde, incentivando a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimentos. Essa integração não apenas aprimora a qualidade do atendimento prestado, mas também fortalece o vínculo entre os profissionais e a comunidade, elevando a confiança dos usuários nos serviços de saúde locais[3],4.

Em síntese, o Apoio Matricial representa uma mudança significativa na concepção e na entrega dos cuidados de saúde na APS. Ao enfatizar a colaboração interdisciplinar, o desenvolvimento de competências clínicas e a implementação de práticas baseadas em evidências, ele não apenas aprimora os resultados em saúde, mas também fortalece o sistema de saúde como um todo, tornando-o mais resiliente e responsivo às necessidades da população atendida[3].

Implementação e Desafios

A implementação do Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde (APS) requer uma abordagem meticulosa que envolve a coordenação eficaz entre os Núcleos de Apoio

à Saúde da Família (NASF) e as equipes de Saúde da Família (eSF). Este processo inicia-se com a realização de reuniões regulares entre os profissionais do NASF e as equipes de eSF, as quais são essenciais para alinhar estratégias de cuidado, revisar protocolos e avaliar continuamente os resultados. Tais encontros facilitam a troca de conhecimento e experiências, promovendo uma abordagem colaborativa e integrada na gestão das condições de saúde da comunidade11.

Na prática, o Apoio Matricial materializa-se por meio de consultas conjuntas e visitas domiciliares coordenadas. Tais práticas ampliam o acesso aos cuidados e aprimoram a continuidade do atendimento, permitindo que as equipes de eSF e os especialistas do NASF atuem em conjunto para atender às necessidades dos usuários de maneira mais holística e integrada[1]. A educação permanente e a formação dos profissionais são igualmente fundamentais para o sucesso do Apoio Matricial. Programas de capacitação auxiliam os profissionais a se familiarizarem com as práticas de matriciamento e a desenvolverem as competências necessárias para implementar eficazmente as estratégias de cuidado, sendo essencial em áreas onde há lacunas de conhecimento sobre o matriciamento12.

Estratégias de Implementação

Para uma implementação bem-sucedida do Apoio Matricial, recomenda-se a realização de reuniões interequipes periódicas, a promoção de consultas conjuntas e visitas domiciliares coordenadas, e a oferta contínua de programas de educação permanente e capacitação para todos os profissionais envolvidos.

Entretanto, a implementação do Apoio Matricial enfrenta desafios significativos. A carência de conhecimento adequado sobre o Apoio Matricial entre gestores e profissionais de saúde pode comprometer a aplicação das práticas e ferramentas propostas, resultando em uma implementação ineficaz. Isso abrange a ausência de participação ativa dos profissionais e o estigma associado às condições de saúde, o qual pode impactar a adesão ao modelo12. Adicionalmente, dificuldades relacionais e organizacionais são frequentemente observadas, com problemas como a fragmentação do cuidado e a ausência de uma abordagem sistemática, que enfraquecem a integração entre os serviços (Conforme estudo qualitativo que objetivou analisar as concepções sobre matriciamento em saúde mental6).

Barreiras na Implementação

A falta de conhecimento sobre o Apoio Matricial, o estigma associado a condições de saúde (especialmente mental), e as dificuldades relacionais e organizacionais podem comprometer a eficácia do matriciamento. É crucial abordar essas barreiras por meio de estratégias de comunicação, desestigmatização e fortalecimento dos vínculos interprofissionais.

A formação acadêmica inadequada dos profissionais constitui outro desafio identificado. A ausência de uma base sólida em práticas de matriciamento pode limitar a capacidade dos profissionais de aplicar efetivamente as estratégias propostas. A educação permanente é essencial para superar tais barreiras e aprimorar a compreensão e a eficácia das práticas matriciais12. Adicionalmente, um estudo conduzido em Itapevi, SP, evidenciou dificuldades específicas nas ações de saúde na Atenção Básica, tais como a baixa capacidade de identificar demandas e riscos, a tendência à medicalização e a reduzida participação dos usuários. Não obstante essas dificuldades, foram alcançados avanços significativos na percepção dos trabalhadores e na mobilização de recursos internos para o cuidado, servindo como base para a introdução do matriciamento13.

Práticas do Apoio Matricial

Na prática, o Apoio Matricial materializa-se por meio de consultas conjuntas, visitas domiciliares coordenadas, grupos terapêuticos e outras intervenções que respondem de forma abrangente às demandas variadas de saúde[1]. Tais práticas não apenas ampliam o acesso aos cuidados, mas também aprimoram a continuidade do atendimento, garantindo uma resposta mais efetiva às necessidades específicas dos usuários, especialmente aqueles com condições crônicas e complexas.

Um estudo analisou as práticas e concepções do matriciamento em saúde mental sob as perspectivas de equipes de referência, equipes matriciais e gestores. Foram realizadas entrevistas com 41 participantes e observações totalizando 110 horas das práticas matriciais. O estudo revelou duas principais concepções sobre o matriciamento: como uma oportunidade de encontro produtivo entre equipes de saúde e como uma estratégia de formação em serviço. As observações confirmaram a necessidade de criar, sistematizar e fortalecer espaços de diálogo entre equipes de referência, equipes matriciais e gestores para consolidar o matriciamento e aprimorar suas práticas5.

Potencialidades para o Futuro

Para o futuro, o Apoio Matricial pode expandir-se por meio da integração intersetorial com serviços sociais, educacionais e comunitários9. Esta integração é crucial para fortalecer as redes de cuidado, permitindo uma abordagem mais holística dos determinantes sociais da saúde. A colaboração com esses setores pode não apenas aprimorar o acesso e a qualidade dos serviços, mas também promover ações preventivas e educativas que são fundamentais para a saúde comunitária.

Adicionalmente, a implementação de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) pode otimizar a gestão de casos e facilitar o compartilhamento de informações entre as equipes de Saúde da Família (eSF) e os serviços especializados. As TICs possuem o potencial de aprimorar a coordenação dos cuidados, apoiar a educação permanente dos profissionais de saúde e garantir que informações cruciais estejam acessíveis a todos os envolvidos no cuidado. Tais inovações tecnológicas podem contribuir para uma gestão mais eficiente e integrada dos cuidados, elevando a qualidade dos serviços prestados.

Um exemplo relevante dessa abordagem é a proposta de intervenção desenvolvida na Região de Saúde de Cruz das Almas. Esta proposta visa aprimorar a articulação entre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e os serviços existentes, por meio da criação e implementação de uma matriz de intervenção adaptada às necessidades locais. O objetivo é promover espaços para a promoção e prevenção em saúde, além de oferecer um cuidado integrado na Atenção Básica. A proposta inclui a realização de encontros de avaliação e adequação para garantir que a implementação seja eficaz e atenda às necessidades da comunidade local8.

Adicionalmente, uma perspectiva valiosa sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na Atenção Primária pode ser abordada no contexto do matriciamento. Um estudo qualitativo, desenvolvido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de um município do Rio Grande do Sul, destaca a necessidade urgente de investimentos e suporte para aprimorar as ações de promoção da saúde e prevenção. O artigo identifica o matriciamento como uma potencialidade para fortalecer a atuação da

Atenção Primária, sugerindo que um maior investimento na formação e no suporte das equipes pode ter um impacto significativo na qualidade e eficácia dos cuidados oferecidos na Atenção Básica10.

Adicionalmente, um estudo qualitativo realizado na Região Sul do Brasil revelou que, apesar dos esforços para aprimorar o cuidado, ainda persiste um descompasso entre as intenções dos apoiadores e as expectativas dos profissionais de saúde. Este conflito aponta para a necessidade de reavaliação das práticas e políticas públicas a fim de garantir que o Apoio Matricial possa efetivamente promover a saúde e a cidadania na Atenção Primária à Saúde7.

Por fim, é crucial incorporar uma perspectiva culturalmente sensível no planejamento e na prática do Apoio Matricial. Embora os profissionais reconheçam a importância dos condicionantes socioculturais nos casos clínicos e nas interações com usuários e comunidades, a competência cultural ainda se mostra insuficiente para uma compreensão crítica da diversidade cultural. Estimular o debate sobre as dimensões socioculturais e considerar as particularidades culturais pode representar um avanço significativo no cuidado colaborativo, auxiliando na superação de desafios e potencializando as práticas matriciais. A integração da cultura no planejamento e na prática não apenas aprimora a adesão às intervenções, mas também eleva a eficácia das estratégias de cuidado na Atenção Primária, conforme evidenciado por pesquisa qualitativa que ressalta a importância de estimular o debate em torno das dimensões socioculturais e considerar as particularidades culturais para o aprimoramento do Apoio Matricial5.

Conclusão

O Apoio Matricial representa uma evolução significativa na forma como a APS aborda as complexidades de saúde da população. Ao integrar saberes e práticas, esta estratégia não apenas fortalece a capacidade de resposta das equipes de eSF e NASF, mas também promove uma abordagem mais humanizada e centrada no usuário. A colaboração interdisciplinar, baseada em evidências e centrada no usuário, é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde pública, garantindo cuidados mais integrados e eficazes.

Padronização da terminologia "equipes de Saúde da Família" para "eSF" em todo o texto, conforme terminologia do Ministério da Saúde.

Verificar se a referência 6 (IGLESIAS, 2021) é a mais adequada para sustentar a afirmação sobre "dificuldades relacionais e organizacionais", ou se há uma fonte mais específica para esses desafios. A referência citada foca nas concepções sobre matriciamento em saúde mental, e não diretamente nas dificuldades relacionais e organizacionais de forma explícita no resumo.

REFERÊNCIAS

[1]COHEN, Marina Chansky. Impasses e potências: o matriciamento como dispositivo de cuidado. Interface (Botucatu, Online), v. 25, e200462, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.200462>.

[2]Como o apoio matricial pode ser desenvolvido na Atenção Básica em Saúde/Atenção Primária em Saúde? Biblioteca Virtual em Saúde, 2015. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/como-o-apoio-matricial-pode-ser-desenvolvido-na-atencao-basica-em-saudeatencao-primaria-em-saude/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

[3]GUSMÃO, Ricardo. Atuação do enfermeiro em saúde mental na estratégia de saúde da família. Journal of Health and Biological Sciences, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v10i1.3721.p1-6.2022>.

4FAGUNDES, Giselle Soares. Matriciamento em Saúde Mental: análise do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico na Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 6, pp. 2311-2322, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.20032019>.

5IGLESIAS, Alexandra. Matriciamento em Saúde Mental: práticas e concepções trazidas por equipes de referência, matriciadores e gestores. Ciência & Saúde Coletiva (online), v. 24, n. 4, pp. 1247-1254, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.05362017>.

6IGLESIAS, Alexandra. Conhecendo o matriciamento em saúde mental pela perspectiva dos matriciadores. Espaç.saúde, v. 22, 2021, pp. 1-12, 24. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353631>.

7OLIVEIRA, Gustavo Costa de. Ações do apoio matricial na Atenção Primária à Saúde: estudo fenomenológico. Acta Paulista de Enfermagem (online), v. 32, n. 6, pp. 674-682, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900093>.

8SANTANA, Elisangela Ferreira de. Proposta de Matriciamento em Saúde Mental nos municípios da Região de Saúde de Cruz das Almas. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola Estadual de Saúde Pública, Salvador, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129712>.

9SANTOS, Angela Maria. O matriciamento em saúde mental como dispositivo para a formação e gestão do cuidado em saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva (online), v. 30, n. 04, e300409, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300409>.

10SANTOS, Elitiele Ortiz dos. Avaliação das estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na rede psicossocial. Escola Anna Nery (online), v. 27, e20220110, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0110pt>.

11SOUSA, Paulo Henrique Caetano de. Relato da implantação do matriciamento em um município cearense: dos desafios às conquistas. Rev. baiana saúde pública, v. 45, n. 4, pp. 241-251, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n4.a3422>.

12VASCONCELO, Marilena Silva de. Conhecimento de gestores e profissionais da rede de atenção psicossocial sobre matriciamento em saúde mental. Ciênc. cuid. saúde, v. 18, n. 4, e43922, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v18i4.43922>.

13YAMAGUTI, Claudiney Augusto. Grupos de reflexão em Saúde Mental: possibilidade de interlocução entre a Saúde Mental e a Atenção Básica no município de Itapevi – SP. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), v. 20, n. 1, pp. 132-138, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1009105>.

Links para Atualização:

Ministério da Saúde - Atenção Primária à Saúde: < https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sas/dab/atencao-primaria-a-saude>

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC): < https://www.sbmfc.org.br/>

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) - Atenção Primária à Saúde: < https://www.paho.org/pt/topicos/atencao-primaria-saude>